

LUXACIÓN DE LA ARTICULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR

Marta Peña Barreno, Raúl Antúnez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez

INTRODUCCIÓN

Definición

Según la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, la luxación de la articulación temporomandibular (ATM) es la separación completa de las superficies articulares (cóndilo y fosa-eminencia) asociada a la colocación del cóndilo mandibular en una posición anormal (habitualmente por delante de la eminencia articular). Cuando el paciente por sí mismo es capaz de recolocar el cóndilo dentro de la fosa glenoidea se denomina subluxación. Si esta reducción es imposible y requiere de determinadas técnicas para recolocar los componentes articulares, hablamos de luxación.

Epidemiología. Factores de riesgo. Etiología.

La luxación de articulación temporomandibular es infrecuente, con una incidencia anual de 5.3 de cada 100.000 pacientes que acuden a un servicio de urgencias.

Suele afectar a adultos jóvenes entre 25 y 45 años, y es más frecuentes en mujeres. Generalmente es bilateral. Los desencadenantes más frecuentes son actividades que impliquen una apertura oral amplia, como el bostezo, la risa o la masticación.

Son menos comunes los desencadenantes iatrogénicos, como la medicación antidopaminérgica, o en relación con una apertura oral forzada o prolongada, como intubación, endoscopias y tratamientos dentales largos entre otros.

En el caso de pacientes con luxación temporomandibular recidivante ésta puede aparecer durante las actividades normales.

La luxación temporomandibular es más frecuente en pacientes con enfermedades neurológicas y neuromusculares, y en pacientes hiperlaxos. Otro factor de riesgo es el edentulismo, por la falta de soporte posterior. Por ello, en una población cada vez más envejecida es de esperar un aumento en la incidencia.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es generalmente clínico, al encontrar la mandíbula fija en la posición de apertura, con incapacidad por parte del paciente para cerrarla, lo que hace que en ocasiones acudan con dificultad para la ingesta y el habla. Suelen presentar además dolor, maloclusión, depresión preauricular y prominencia de la cabeza condilar. Otros posibles síntomas son hipersalivación y contractura de la musculatura masticatoria.

En pacientes de edad avanzada con mucha morbilidad los síntomas a veces son menos llamativos, lo que unido a una menor comunicación de éstos hace que el diagnóstico tardío sea común, complicándose el manejo en este grupo.

También puede pasar inadvertida en pacientes sedados, post trauma o con luxación crónica.

Las pruebas de imagen (ortopantomografía, TC) pueden ser útiles como confirmación diagnóstica, o en los casos que cursen de manera atípica.

TRATAMIENTO

La luxación de la articulación temporomandibular debe ser tratada cuanto antes. El tratamiento de primera elección en las luxaciones agudas es la reposición manual.

Esto debería poder hacerse en cualquier servicio de urgencias. Cuanto más precoz sea la reducción antes se aliviará el dolor y la angustia del paciente y más fácil será (menor espasmo muscular). Además, la demora aumenta el riesgo de luxaciones recurrentes.

Si no se consigue debe remitirse al paciente lo antes posible a un hospital con especialistas de Cirugía Maxilofacial de guardia.

El método más comúnmente usado para la reducción de luxaciones no traumáticas es el hipocrático (figura 1). Durante la realización de la maniobra la cabeza del paciente debe estabilizarse sobre un respaldo.

Existen otras técnicas de reducción. Destaca la técnica extraoral, indicada si existe alto riesgo de mordida o infección, entre otros. Esta técnica requiere más tiempo, tiene un porcentaje de éxito menor y es más dolorosa para el paciente.

Si no se consigue la reducción en un primer intento, puede ser de ayuda la administración de relajantes musculares y/o analgesia, o incluso, si es preciso, sedación o anestesia general.

En luxaciones crónicas de más de 3 a 4 semanas de evolución las maniobras no suelen ser eficaces, en cuyo caso debe remitirse al paciente al especialista para valorar otras posibilidades terapéuticas.

Como medidas post reducción debe realizarse inmovilización por un corto periodo de tiempo, dieta blanda, pauta de analgesia y fisioterapia (ejercicios de apertura

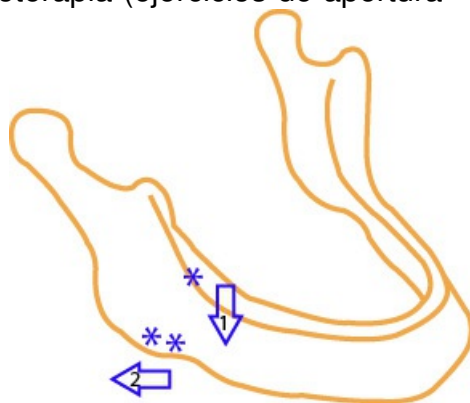


Figura 1. Método hipocrático para reducción de la luxación mandibular. En primer lugar debe posicionarse el pulgar sobre la mandíbula (en la línea oblicua externa, localizada lateral a la arcada dentaria, para evitar ser mordido) y el resto de los dedos en la basal mandibular. A continuación se ejerce presión primero hacia caudal y posteriormente hacia dorsal (indicado con las flechas).

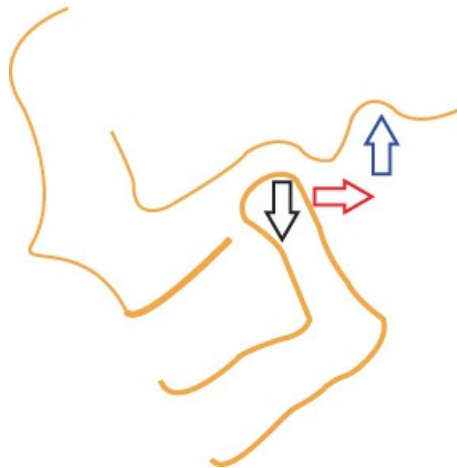


Figura 2. Cóndilo luxado en posición anterior (lo más frecuente). Las flechas indican los movimientos a realizar para reintroducirlo en la fosa glenoidea (1º negro, 2º rojo, 3º azul).



Luxación temporo mandibular izquierda

Puntos clave

- El diagnóstico es generalmente clínico, al encontrar la mandíbula fija en la posición de apertura.
- El tratamiento deber realizarse lo antes posible. Si no se consigue la reducción debe remitirse al paciente a un hospital con cirujano maxilofacial de guardia.

BIBLIOGRAFÍA

- Fernández Sanromán J, Vázquez Salgueiro E, Cebrián Carretero J. Luxación recidivante de la articulación temporomandibular. En: Protocolos clínicos de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial de Cabeza y Cuello [Internet] [Accesed on November 2019]. Available in: <http://www.secom.org/area-profesional/protocolos-clinicos-de-la-secom>.
- Prechel U, Ottl P, Ahlers OM, Neff A. The treatment of temporomandibular joint dislocation—a systematic review. Dtsch Arztebl Int. 2018;115(5):59–64.
- Katti G, Shahbaz S, Chaubey SS, Khan M. Management of temporomandibular joint dislocation: review of literature. Int J Sci Res. 2016;5:574–7.